# 前庭神経炎の鑑別診断

## — 脳卒中を見逃さないためのアプローチ —

医知創造ラボ　今村久司

*Barany Society 2022 分類 / GRACE-3 ガイドライン準拠*

# 前庭神経炎とは ー 疾患概念

**AUVP（Acute Unilateral Vestibulopathy）**
= 急性一側前庭障害 ≒ 前庭神経炎

**1**

急性に生じた一側の
末梢前庭機能低下
による持続性めまい

**2**

急性の中枢神経症状
がないこと

**3**

急性の聴覚症状
がないこと

# 病態と原因

## 病態は十分には解明されていない

**ウイルス関連炎症説**　感染後の炎症反応を支持するレビューあり

**血管性機序**　前庭神経への血流障害が提案されている

**免疫学的機序**　自己免疫的プロセスの関与も指摘

*→ 単一の病因では説明できず、複数の機序が関与する可能性*

# 症状の特徴

## 典型的な症状

**持続性の強いめまい**
（24時間以上持続）

- ふらつき
- 悪心・嘔吐
- 頭部回旋時の増悪
- Oscillopsia
  （物が揺れて見える）

## 典型的でない症状

**以下は前庭神経炎に合わない**

- 急性の難聴
- 耳鳴り
- 耳閉感

→ 診断を立て直す

# 診察：前庭神経炎に合う所見

1

**方向固定性の水平回旋混合性自発眼振**

視固定を外すと増強する（Frenzel眼鏡下で確認）

2

**一側のVOR（前庭眼反射）低下**

Head Impulse Testで評価

患側に素早く頭部回旋 → catch-up saccade 出現

# 中枢性めまいを疑う所見

- ❗ Skew deviation（垂直性の眼位ずれ）
- ❗ 注視方向で変わる眼振（gaze-evoked nystagmus）
- ❗ 垂直眼振 / 純回旋性眼振
- ❗ 強い体幹失調 / 歩行不能
- ❗ 明らかな神経巣症状

**Head Impulse Test 単独では脳卒中を除外できない**

# HINTSの位置づけと注意点

**H**ead-Impulse / **N**ystagmus / **T**est of **S**kew

| 適用条件 | 適用外 |
| --- | --- |
| ・自発眼振を伴う持続性AVS<br>・訓練された診察者が実施 | ・頭位誘発性のめまい（BPPV）<br>・反復発作性のめまい |

*GRACE-3 (2023): 訓練なしの救急現場でroutineに行われるHINTSは不正確であり、standard of careとは言えない*

# 鑑別診断 — 主要5疾患

| 疾患 | 性状 | 持続時間 | 鑑別のポイント |
|---|---|---|---|
| **前庭神経炎** | 持続性・自発性 | 24時間以上 | 一側VOR低下、聴覚症状なし |
| **BPPV** | 頭位変換誘発 | 数秒〜1分 | Dix-Hallpike陽性 |
| **メニエール病** | 反復発作性 | 20分〜12時間 | 変動性聴覚症状を伴う |
| **前庭性片頭痛** | 反復性・多彩 | 5分〜72時間 | 片頭痛の病歴・症状関連 |
| **脳幹・小脳梗塞** | 持続性・急性 | 持続 | 中枢性眼振、skew、失調 |

**最重要の鑑別 = 脳幹・小脳梗塞（片麻痺や構音障害がなくても安心できない）**

# 検査の進め方

**1**

持続性の
急性前庭症候群か

**2**

一側VOR低下
を示せるか

**3**

聴覚症状や
中枢所見がないか

## 画像検査の位置づけ（GRACE-3）

✖ AVSでのbrain CTは勧めない

△ HINTSに熟練した診察者がいればroutine MRIはfirst-lineにしない

○ HINTSが中枢性/判定不能 → MRIをconfirmatory testに

# 治療：急性期の支持療法

**1**

悪心・嘔吐の軽減

**2**

脱水予防

**3**

離床のきっかけを作る

## 制吐薬・前庭抑制薬の使い方

**初期数日**
症状緩和に有用

→

**長期使用は避ける**
中枢代償を妨げる
可能性あり

# ステロイドの位置づけ — エビデンスの変遷

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2004** | **Strupp (NEJM)** | methylprednisolone RCT<br>P<0.001 | **有意に改善** |
| **2021** | **Leong (SR/MA)** | 短期改善示唆<br>長期根拠不十分 | **限定的** |
| **2022** | **Bogdanova (MA)** | 一定の利益<br>研究の質に問題 | **慎重な解釈** |
| **2025** | **Sjogren (RCT)** | プラセボ対照<br>二重盲検 N=69 | **有意差なし** |

**GRACE-3:「短期ステロイドを考慮してよい」＝ 全例標準投与ではない**

# 前庭リハビリテーション

**比較的しっかりしたエビデンスがある治療**

Cochrane 2015 + メタ解析 2024 で有効性支持

**リハビリ + ステロイド併用 > ステロイド単独**

| NG：安静を長引かせる | OK：安全に動かして代償促進 |
| --- | --- |
| 安静 → 代償遅延<br>前庭抑制薬の長期使用<br>**→ 回復が遅れる** | 嘔吐が落ち着いたら<br>抑制薬を切り上げ<br>**→ 運動療法へ** |

# 予後

**急性期の回転感**
時間とともに軽減していくことが多い

**しかし一部の患者では…**
・慢性の浮動感が残存
・Visual dependence（視覚依存性めまい）

**長期予後は末梢障害の程度だけでは説明できない**
中枢代償側の因子（anxiety等）が関与

**経過が非典型なら鑑別のやり直しが必要**

# 見逃してはいけない所見

1. 注視方向で変わる眼振 / 垂直眼振 / 純回旋性眼振 / skew deviation
2. 強い体幹失調 / 歩行不能 / 明らかな神経巣症状
3. 急性の難聴 / 耳鳴り / 耳閉感を伴う
4. HINTSが中枢性 or 判定不能 / 適切な訓練がない
5. MRIが早期陰性でも臨床的に疑わしい

**「画像が陰性だから末梢性」と短絡しない**

# 実地診療での要点（Take-Home Message）

1. 前庭神経炎は臨床診断 → 最優先は脳卒中除外
2. 難聴・skew・垂直眼振・歩行不能は典型VNから外れる
3. HINTSは「持続性AVS ＋ 訓練された診察者」が条件
4. CT陰性≠stroke除外、早期MRI陰性でも安心しない
5. 治療の柱 = 支持療法 ＋ 前庭リハビリ（ステロイドは個別判断）

*ご視聴ありがとうございました*